Evaluar en promoción de la salud: por qué y cómo

SESIÓN 2 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Propuesta docente en revisión: 31/10/2026. Pendiente de validación institucional.

Una sesión práctica: justificar la necesidad de evaluar y ensayar sus fundamentos, técnicas y herramientas: preguntas, indicadores, checklists, registros, matriz y devolución.

Qué aprenderemos

- Argumentar por qué una actuación de promoción de la salud debe evaluarse y qué se pierde si no se prevé desde el inicio.
- Distinguir seguimiento y evaluación, proceso, resultados e impacto, contribución y atribución.
- Construir una ficha de indicador con tiempo cero, meta, fuente y responsable.
- Usar las checklists de planificación y evaluación de EpS grupal para revisar una actuación.
- Leer críticamente un registro de actividad y montar una matriz de evaluación proporcionada.
- Diseñar la devolución de resultados a distintos destinatarios.

Agenda

09:00–09:15
Retorno de las actividades A y B

09:15–09:40
Práctica 1 · ¿Funcionó? Lo que permite y lo que no permite afirmar una hoja de firmas

09:40–10:15
Práctica 2 · Clasificar preguntas de evaluación: seguimiento, proceso, resultados, impacto

10:15–11:00
Práctica 3 · Taller de fichas de indicador sobre el plan de cada grupo

11:00–11:30
Descanso

11:30–12:20
Práctica 4 · Checklists de planificación y evaluación aplicadas a una actuación grupal

12:20–13:10
Práctica 5 · Registros de actividad (RAPS) y matriz de evaluación con RE-AIM

13:10–13:45
Práctica 6 · Diseñar la devolución a tres destinatarios

13:45–14:00
Cierre: para qué planificar y evaluar. Presentación de las actividades virtuales V2

Evaluar en promoción de la salud: por qué y cómo

SESIÓN 2 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Práctica 1 · ¿Funcionó? (25 minutos)

Supuesto didáctico, no un hecho del expediente: en Zagra se organiza durante un trimestre un grupo de paseo para personas mayores que viven solas. Al final solo se dispone de la hoja de firmas de cada sesión. En grupos:

- ¿Qué puede afirmarse con la hoja de firmas? ¿Cuántas personas distintas participaron, si no hay un identificador único?
- ¿Puede afirmarse que disminuyó la soledad? ¿Qué habría hecho falta medir y cuándo?
- ¿Quién quería saber si funcionó y para decidir qué?
- Tiempo: 15 minutos de trabajo en grupo y 10 de puesta en común.

Práctica 2 · Clasificar preguntas de evaluación (35 minutos)

Clasificar ocho preguntas sobre el plan de Zagra según la tabla de fundamentos y señalar, para cada una, con qué se compara. Después, discutir qué es razonable esperar en un municipio de 843 habitantes.

- ¿qué proporción de las 198 personas de 65 años o más ha participado en alguna actuación? ¿Han participado hombres y mujeres, y población de nacionalidad extranjera?
- ¿ha disminuido la soledad percibida en las personas incorporadas a la intervención, medida con la misma escala al inicio y en el seguimiento?
- ¿cuántos de los activos registrados en Localiza Salud participan en el plan?
- ¿se mantuvieron las actividades previstas? ¿Qué se adaptó?
- ¿siguen las actuaciones cuando cambia el personal del consultorio o la corporación municipal? En Zagra, el ciclo de 2017-2018 no consta que se completara.
- ¿Ha bajado la mortalidad por enfermedad cardiovascular en Zagra al final del plan?
- ¿Se celebraron las reuniones previstas del Grupo Motor?
- ¿Qué opinan las personas participantes de los talleres?
- Tiempo: 10 minutos de fundamento, 15 de trabajo en grupo y 10 de puesta en común.

Fundamento · Seguimiento y evaluación

¿Estamos haciendo lo que planificamos?
Tipo: Seguimiento de proceso · Compara con: Lo planificado

¿Llega a quien debía llegar y como estaba previsto?
Tipo: Evaluación de proceso · Compara con: El diseño de la actuación

¿Han cambiado los determinantes, conocimientos, conductas o condiciones?
Tipo: Evaluación de resultados · Compara con: El tiempo cero

Evaluar en promoción de la salud: por qué y cómo

SESIÓN 2 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

¿Ha mejorado la salud de la población?
Tipo: Evaluación de impacto · Compara con: El tiempo cero y, si es posible, un territorio de comparación

Fundamento · Contribución y atribución

En un plan local de cuatro años rara vez puede atribuirse un cambio en la salud de la población a las actuaciones del plan: influyen otros factores y el tamaño de la población limita la precisión. Lo razonable suele ser evaluar el proceso con exhaustividad, los resultados intermedios con rigor y el impacto como contribución plausible, declarando los límites. Prometer impacto atribuible que no podrá demostrarse debilita la credibilidad del plan. Zagra lo muestra con claridad: 17 defunciones en 2015 dieron una tasa bruta de 18,9 por mil; con esa población, la variación de un año a otro puede deberse al azar. Un plan local para un municipio de este tamaño debe evaluarse sobre todo por su proceso y por los cambios en las personas participantes.

Práctica 3 · Taller de fichas de indicador (45 minutos)

Cada grupo elige un objetivo específico de su plan (actividad B de V1) y completa la ficha de un indicador de resultado. Después intercambia la ficha con otro grupo, que intenta calcular el indicador solo con lo escrito: si no puede, la ficha está incompleta.

- Tiempo: 10 minutos de fundamento, 25 de trabajo en grupo con intercambio de fichas y 10 de puesta en común.

Nombre
Breve y sin ambigüedad

Tipo
Proceso, resultado o impacto

Definición operativa
Qué se cuenta exactamente

Numerador y denominador
Con unidad y población de referencia

Fuente
Registro, encuesta, padrón u otra; quién custodia el dato

Frecuencia
Cuándo se mide

Tiempo cero
Valor de partida y fecha, registrado antes de ejecutar

Meta
Valor esperado al final del periodo y justificación

Evaluar en promoción de la salud: por qué y cómo

SESIÓN 2 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Responsable de medición
Cargo

Cautelas
Qué no puede concluirse con este indicador

Fundamento · Indicadores locales y autonómicos

La EPVSA asocia cada objetivo estratégico a indicadores de contexto (situación de partida) e indicadores de impacto, muchos procedentes de la Encuesta Andaluza de Salud. Esa lógica, partida y llegada medidas con la misma definición, es la que se pide a cada indicador local. Un indicador autonómico no suele tener resolución municipal: no sirve como tiempo cero de un plan local si no se dispone del dato para el municipio. En Zagra, los indicadores de envejecimiento saludable de COMPÁS (véase V1) se miden en las personas participantes, no en la población: son indicadores de resultado de una actuación. Con 843 habitantes, una encuesta poblacional repetida puede ser factible, pero hay que decidirlo antes de empezar.

Técnica · Reglas de prudencia con los datos

- No promediar porcentajes de actuaciones distintas para obtener un indicador agregado.
- No sumar participantes de varias actividades sin eliminar duplicados.
- No usar un indicador de actividad del servicio como indicador de necesidad.
- Si no hay tiempo cero, decirlo y planificar su medición antes de empezar.

Práctica 4 · Checklists aplicadas a una actuación grupal (50 minutos)

En parejas, aplicar la checklist de planificación (44 ítems) a la actuación grupal descrita en la actividad B de V1, y la checklist de evaluación (33 ítems) a su sistema de evaluación previsto. Interesa menos el porcentaje total que las secciones con menor cumplimiento: cada pareja anota tres mejoras. Herramientas: https://bhermoso.github.io/aula-activos-comunitarios/planificacion-evaluacion/herramientas/checklist-planificacion.html y https://bhermoso.github.io/aula-activos-comunitarios/planificacion-evaluacion/herramientas/checklist-evaluacion.html

- Lista de comprobación de planificación: análisis de la situación, objetivos, contenidos y metodología, recursos y logística, cronograma, evaluación, y actores y coordinación.
- Lista de comprobación de evaluación: planificación de la evaluación, proceso, resultados, impacto, instrumentos, y análisis y uso de resultados.
- Guardar o imprimir el resumen de cada checklist: se usará en V2.
- Tiempo: 5 minutos de presentación de las herramientas, 35 de trabajo en parejas y 10 de puesta en común.

Práctica 5 · Registros y matriz de evaluación (50 minutos)

Primera parte (20 minutos): a partir de la descripción del RAPS, decidir qué preguntas del plan puede responder un registro

Evaluar en promoción de la salud: por qué y cómo

SESIÓN 2 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

de actividad y cuáles no. Segunda parte (30 minutos): construir la matriz de evaluación del plan del grupo para tres preguntas, usando las dimensiones RE-AIM.

- Puede informar: qué actividades se hicieron, dónde, cuándo, con qué temática y cuántas sesiones.
- Requiere cautela: la exhaustividad depende de que se registre todo lo realizado; sin registro no se puede afirmar que algo no se hizo.
- No puede informar por sí solo: si las personas cambiaron sus conductas o si mejoró su salud.
- Asistencias no equivalen a personas: sin identificador único no se eliminan duplicados.
- Tiempo: 10 minutos de fundamento, 30 de trabajo en grupo y 10 de puesta en común.

Técnica · Matriz de evaluación y RE-AIM

Pregunta de evaluación
Qué se quiere saber y para qué decisión

Indicador o información
Cuantitativa o cualitativa

Fuente e instrumento
Registro, cuestionario, entrevista, grupo, observación

Momento
Tiempo cero, durante la ejecución, al final, seguimiento

Responsable
Cargo

Uso previsto
Quién recibirá el resultado y qué podrá decidir con él

Técnica · Dimensiones RE-AIM

Alcance
¿Qué proporción de la población destinataria participó? ¿Quién quedó fuera?

Efectividad
¿Qué cambió en quienes participaron?

Adopción
¿Qué entidades y profesionales se sumaron?

Evaluar en promoción de la salud: por qué y cómo

SESIÓN 2 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Implementación
¿Se hizo lo previsto? ¿Qué se adaptó y por qué?

Mantenimiento
¿Continúa la actuación cuando termina el apoyo inicial?

Práctica 6 · Diseñar la devolución (35 minutos)

Para un mismo resultado del plan, preparar tres devoluciones: al Grupo Motor y la corporación (para decidir), a los equipos que ejecutan (para mejorar) y a la comunidad (para rendir cuentas). Elegir formato, momento y quién la presenta.

- Métodos que pueden alimentar la devolución:
- Grupos de discusión y entrevistas: por qué funcionó o no, para quién y en qué condiciones.
- Técnica del cambio más significativo: relatos de cambio seleccionados colectivamente.
- Observación y diario de campo de las actividades.
- Evaluación con la comunidad: el Grupo Motor y los participantes interpretan los resultados, no solo los reciben.
- Tiempo: 5 minutos de fundamento, 20 de trabajo en grupo y 10 de puesta en común.

Herramientas que se usan en la sesión

- Checklist de planificación de EpS grupal: https://bhermoso.github.io/aula-activos-comunitarios/planificacion-evaluacion/herramientas/checklist-planificacion.html
- Checklist de evaluación de EpS grupal: https://bhermoso.github.io/aula-activos-comunitarios/planificacion-evaluacion/herramientas/checklist-evaluacion.html
- Plantillas de ficha de indicador y de plan de evaluación (CSV).
- Descripción del RAPS (Registro de Actuaciones de Promoción de la Salud, REDCap).

Criterio de cierre

Cada grupo sale con una ficha de indicador revisada por otro grupo, los resúmenes de las dos checklists con tres mejoras cada uno y una matriz de evaluación de tres preguntas, que completará en las actividades virtuales V2.

Caso de trabajo: Zagra, con datos del expediente territorial y sus fuentes. No incorporar datos personales ni información clínica individual en los trabajos.